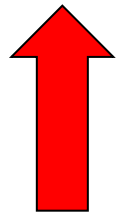


Αναπνευστική οξέωση

$$\text{pH} < 7,4 \text{ και } \text{pCO}_2 > 40 \text{ mmHg}$$

Αίτια: νοσήματα ή διαταραχές της νευρομυϊκής αντλίας και του πνεύμονα που προκαλούν κυψελιδικό υποαερισμό και άρα υπερκαπνία

Υποαερισμός

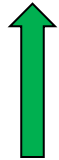

$$PaCO_2 = k \frac{VCO_2}{V_A}$$


Αναπνευστική οξέωση $\text{pH} < 7,4$ και $\text{pCO}_2 > 40 \text{ mmHg}$

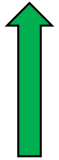
Αντιρρόπηση στην αναπνευστική οξέωση

οξέως

1 meq/L  $[\text{HCO}_3^-]$ από τα 24 (mEq/L)

για κάθε 10 mmHg  της pCO_2 από τα 40 (mmHg)

χρονίως

• 3,5 meq/L  $[\text{HCO}_3^-]$ από τα 24 (mEq/L)

για κάθε 10 mmHg  της pCO_2 από τα 40 (mmHg)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ

pH < 7,4 και PCO₂ > 40 mmHg

Αναπνευστική οξέωση

Πόση είναι η [HCO₃⁻]

↑ [HCO₃⁻] είναι < 1 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Συνυπάρχει
μεταβολική οξέωση

↑ [HCO₃⁻] = 1 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Οξεία αναπνευστική
οξέωση

↑ [HCO₃⁻] = 1-3,5 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

• Περίοδος
μετάβασης
• Μικτή διαταραχή

↑ [HCO₃⁻] = 3,5 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Χρόνια
αναπνευστική οξέωση

↑ [HCO₃⁻] είναι > 3,5 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Συνυπάρχει
μεταβολική αλκάλωση